

浙江省医疗住院收费票据(电子)



票据代码: 33060225

交款人统一社会信用代码: 3***25****01****X

交款人: 曹启迟

票据号码: 4010673992

校验码: 359092

开票日期: 20251226

项目名称	金额 (元)	备注	项目名称	金额 (元)	备注	项目名称	金额 (元)	备注	
诊查费	132.00		护理费	161.50					
检查费	456.00								
治疗费	875.80								
西药费	804.45								
化验费	3362.50								
卫生材料费	214.98								
床位费	360.00								
金额合计 (大写) 陆仟叁佰陆拾柒元贰角叁分						(小写) 6367.23			
其他信息	业务流水号: zjs7759000029417		病历号: 8809593		住院号: 600037005		住院科别: 呼吸与危重症医学科		
	住院时间: 20251220-20251226		预缴金额: 3000.00		补缴金额: 0.00		退费金额: 13.11		
	医疗机构类型: 三级甲等		医保类型: 浙江医保结算		医保编号: 3***00****00*****100676135		性别: 男		
	乙类先行自付: 26.92		个人自费: 2584.38		个人自付: 375.59		参保地: 浙江省温州市		
	医保统筹基金支付: 3380.34		大病基金支付: 0.00		其他支付: 0.00				
	个人账户支付: 0.00 (本年支付: 0.00 本年余额: -14.56 历年支付: 0.00 历年余额: 0.00)								
个人现金支付: 2986.89									
备注: 输血费: 0 用血减免: 0 已支付: 2986.89 欠费: 0									

温州市人民医院

123303814708600641

收款单位: 瑞安市人民医院

复核人: 杨丫丫

浙江财政电子票据查验、下载(含明细): <https://dzpj.zjzfw.gov.cn>

温州医科大学附属第三医院

瑞安市人民医院(47086006-4)

住院病案首页



600037005

医疗付款方式: ☐

健康卡号: F09835357xnjk88095

第1次住院

病历号: 8809593

93

病案号: RX8809593

姓名 曹启迟 性别 ☐ 1.男 2.女 出生日期 1970-01-24 年龄 55岁 国籍 中国
(年龄不足1周岁的) 年龄 新生儿出生体重 克 新生儿入院体重 克
出生地 浙江省温州市瑞安市 籍贯 浙江省温州市瑞安市 民族 汉族
身份证号 33032519700124531X 职业 无业人员 婚姻 ☒ 1.未婚 2.已婚 3.丧偶 4.离婚 9.其他
现住址 浙江省温州市瑞安市莘塍街道莘塍街道里岸南路27弄7号 电话 13705879951 邮编 325200
户口地址 浙江省温州市瑞安市莘塍街道浙江省温州市瑞安市莘塍街道里岸南路27弄7号 邮编 325200
工作单位及地址 单位电话 邮编
联系人姓名 曹巧云 关系 兄、弟、姐、 地址 13705879951 电话 13906876636
入院途径 ☒ 1.急诊 2.门诊 3.其他医疗机构转入 9.其他
入院时间 2025-12-20 09:46 入院科别 呼吸与危重症医学系 病房 22+17 转科科别 -
出院时间 2025-12-26 11:00 出院科别 呼吸与危重症医学系 病房 2204 实际住院 6 天
门(急)诊诊断 肺恶性肿瘤:腺癌 疾病编码 C34.900x001

出院诊断	疾病编码	入院病情	出院诊断	疾病编码	入院病情
主要诊断:社区获得性肺炎,非重症	J15.902	1	其他诊断:-	-	-
其他诊断:低钾血症	E87.600	3	-	-	-
肺腺癌(cT4N3M0)	C34.900x001	1	-	-	-
淋巴结继发恶性肿瘤	C77.900x001	1	-	-	-
腹腔良性肿瘤(神经鞘瘤)	D36.707	1	-	-	-
肝功能不全	K72.905	1	-	-	-
肺部结节	R91.x00x001	1	-	-	-
脾-胃间隙占位	R93.303	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

入院病情: 1.有 2.临床未确定 3.情况不明 4.无

损伤、中毒的外部原因: 疾病编码

病理诊断: - 疾病编码 - 病理号 -

药物过敏: ☐ 1.无 2.有, 过敏药物 死亡患者尸检: ☐ 1.是 2.否血型: ☒ 1.A 2.B 3.O 4.AB 5.不详 Rh: ☐ 1.阴 2.阳 3.不详 4.未查科主任 王仁均 主任(副主任)医师 王仁均 主治医师 陈品卿 住院医师 金 箫责任护士 陈 华 进修医师 实习医师 编码员病案质量: ☐ 1.甲 2.乙 3.丙 质控医师 陈品卿 质控护士 黄一鑫 质控日期: 2025-12-29

手术及操作	手术及操作	手术	手术及操作	手术及操作人员	切口愈	麻醉方式	麻醉医师
编 码	作 日期	级 别	名 称	术者	合等级	I 助	II 助

第1页/共2页

400x002	2025-12-22	-	支气管镜下 诊断性支气 管肺泡灌洗 [BAL]	赵仁 国	金第	-	-/-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

离院方式: ☒ 1. 医嘱离院 2. 医嘱转院, 拟接收医疗机构名称
3. 医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院, 拟接收医疗机构名称4. 非医嘱离院 5. 死亡 9. 其他

是否有出院31天内再住院计划: ☒ 1. 无 2. 有, 目的

颅脑损伤患者昏迷时间: 入院前天小时分钟 入院后天小时分钟

住院费用(元): 总费用6367.23 (自费金额2986.89)

1. 综合医疗服务类: (1)一般医疗服务费462 (2)一般治疗操作费758.2 (3)护理费144
(4)其他费用30

2. 诊断类: (5)病理诊断费105 (6)实验室诊断费3362.5 (7)影像学诊断费115
(8)临床诊断项目费236

3. 治疗类: (9)非手术治疗项目费0 (临床物理治疗费0)
(10)手术治疗费0 (麻醉费0 手术费0)

4. 康复类: (11)康复费0

5. 中医类: (12)中医治疗费117.6

6. 西药类: (13)西药费804.45 (抗菌药物费用0)

7. 中药类: (14)中成药费0 (15)中草药费0

8. 血液和血液制品类: (16)血费0 (17)白蛋白类制品费0 (18)球蛋白类制品费0
(19)凝血因子类制品费0 (20)细胞因子类制品费0

9. 耗材类: (21)检查用一次性医用材料费61.98 (22)治疗用一次性医用材料费133
(23)手术用一次性医用材料费0

10. 其他类: (24)其他费37.5

单病种管理: ☒ 1. 有 2. 无

临床路径管理: ☒ 1. 完成 2. 变异 3. 退出 4. 未入

诊断符合情况: 1. 门诊与出院 ☒ 2. 入院与出院 ☒ 3. 术前与术后 ☒
4. 临床与病理 ☒ 5. 放射与病理 ☒ (0. 未做 1. 符合 2. 不符合 3. 不确定)

抢救情况: 抢救 ☒ 次 成功 ☒ 次

转归情况: ☒ 1. 治愈 2. 好转 3. 未愈 4. 死亡 5. 其他

说明: 医疗付费方式有: 1. 城镇职工基本医疗保险; 2. 城镇居民基本医疗保险; 3. 新型农村合作医疗; 4. 贫困救助;
5. 商业医疗保险; 6. 全公费; 7. 全自费; 8. 其他社会保险; 9. 其他。凡可由医院信息系统提供住院费用清单的, 住院
病案首页中可不填写“住院费用”。

瑞安市人民医院

住院病历

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：22+10 病历号：8809593

入院记录

姓 名：曹启迟 性 别：男
出生日期：1970-01-24 出 生 地：浙江省温州市瑞安市
职 业：无业人员 民 族：汉族
婚 姻：已婚 联系地址：浙江省温州市瑞安市 莘塍街道 莘塍街道里岸南路27弄7号
入院时间：2025-12-20 09:46 病历陈述者：患者本人及姐姐

主诉：咳嗽咳痰3天，发热1天。

现病史：患者3天前无明显诱因下出现咳嗽，阵发性，较剧，咳白色粘液痰，量不多，难以咳出，不伴发热，无胸闷气促，无畏寒寒战，无腹痛腹泻，无头晕头痛，无恶心呕吐，无四肢浮肿等不适，当时未予重视，未予诊治，症状无好转。昨日患者出现发热，体温最高39℃，予“感冒灵”口服后体温反复升高，咳嗽咳痰症状同前。昨日患者遂来我院门诊就诊，门诊查胸部CT示：“左肺上叶MT、左侧第3-4肋骨骨折密度改变，较2025.7.14CT病灶较前缩小，请结合临床进一步检查。右肺上叶炎症伴包裹性积液、积气，请结合临床随诊除外其他。两肺肺气肿，两肺上叶肺大泡。两肺纤维灶。右肺下叶磨玻璃结节灶，右肺下叶及左肺上叶实性微小结节灶，较前片右肺下叶结节新发，请随诊。两侧胸膜增厚。附见：脾-胃间隙占位，胃来源？请结合临床进一步检查。肝门区颗粒状淋巴结影。肝右叶钙化灶。”现患者仍反复发热，咳嗽咳痰症状同前，无胃寒寒战，无恶心呕吐，无腹痛腹泻，无头晕头痛，无四肢浮肿，为进一步诊治，拟“肺恶性肿瘤”收住入院。

发病以来神志清，精神可，食欲较好，睡眠尚可，体重无明显变化，大便无殊，小便无殊。

既往史：健康状况：一般，无“肺结核”病史，无“传染性肝炎”病史。疾病史：有“肺恶性肿瘤”6月病史，2025-6-27在上海市东方医院行“肺穿刺”检查，病理结果示：“低分化癌，结合免疫组化考虑低分化腺癌”。2025-7-10至2025-10-16在上海市东方医院行“化疗联合免疫治疗”，具体方案：“帕博丽珠单抗+培美曲塞+卡铂”。本次治疗时间：2025-10-16开始行帕博丽珠单抗维持治疗。患者于2025-11-20开始行再程放疗。2025-11-20至2025-12-11在上海市东方医院治疗，出院诊断：“1.恶性肿瘤放射治疗 2.肺恶性肿瘤（cT4N3M0） 3.淋巴结继发恶性肿瘤 4.Fuchs综合征 5.腹腔良性肿瘤（神经鞘瘤）”。无“糖尿病”“高血压”、无“冠心病”、无“脑血管病变”、无“慢性阻塞性肺疾病”、无“慢性肾炎”等疾病史。预防接种史不详，无手术史，无外伤史，无中毒史，无输血史，食物过敏史：否认，药物过敏史：否认。无长期用药，无服用可能成瘾药物。

个人史：生于浙江省温州市瑞安市，成长经历地：浙江省温州市瑞安市，居住较长的地区：浙江省温州市瑞安市，居留时间：出生至今，否认疫区居留史，否认疫水疫源接触史，否认不洁性交史，否认有毒物及放射物质接触史，否认吸毒史，否认吸烟史，否认饮酒史，工作：无业人员。家庭关系和睦。

瑞安市人民医院

住院病历

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：22+10 病历号：8809593

婚育史：婚姻史：已婚，24岁结婚，配偶体健，育有1子，儿子体健。

家族史：家族中无类似患者，无慢性传染病。父亲体健；母亲体健；兄弟姐妹健康状况：1姐，体健。家族中遗传倾向性疾病：无。无遗传性疾病。

体格检查

一般情况：意识清晰，体温：38.1℃，脉搏：113次/分，呼吸：20次/分，血压：122/74mmHg，身高：170cm，体重：63kg。自主体位，急性面容，表情焦虑，步入病房，步态正常，查体：合作。

皮肤、黏膜：皮肤黏膜：红润，无水肿，无皮疹，无皮下出血。

浅表淋巴结：耳后、颌下、颈部、腋下、锁骨上下、腹股沟等浅表淋巴结无肿大。

头部及其器官：头颅无畸形，听力粗测正常，结膜无充血，巩膜无黄染，角膜无浑浊，双侧瞳孔等大等圆，左3mm，对光反射灵敏，右3mm，对光反射灵敏，鼻通气畅，副鼻窦无压痛，乳突无压痛，口腔黏膜光整，咽无充血，扁桃体：无肿大，唇红润。

颈 部：颈软，颈静脉无怒张，肝颈静脉回流征阴性，气管位置：居中，甲状腺：无肿大。

胸 部：胸廓无畸形，肋间隙无增宽或变窄，乳房无红肿，无压痛，无包块。

肺 脏：呼吸运动对称，触觉语颤无异常，两侧对称，两肺叩诊呈清音，两肺听诊呼吸音清，未闻及干啰音及湿啰音。无胸膜摩擦音。

心 脏：心尖搏动正常，心前区无触及震颤，心界叩诊正常，心率：113次/分，心律齐，心音有力，无杂音，无心包摩擦音。

血 管：毛细血管搏动征阴性，无水冲脉，无枪击音。

腹 部：腹部平坦，无胃肠型，无蠕动波，腹壁浅静脉无曲张，腹部柔软，无压痛，无反跳痛，腹部无包块。肝脏肋下未触及，胆囊肋下未触及。莫菲氏征阴性。脾脏肋下未触及。双侧肾区无叩击痛，移动性浊音阴性。肠鸣音4次/分。无血管杂音，无振水音。

外生殖器：无畸形

肛门、直肠：无畸形

脊柱四肢：脊柱无畸形，无叩痛，棘突无压痛；四肢形态无异常，无杵状指（趾），无水肿，关节无红肿，无压痛，无活动障碍。

神经系统：四肢肌张力正常，四肢肌力V级，腹壁反射存在，膝腱反射存在，双侧Babinski征阴性，颈无抵抗。双侧Kernig征阴性，Brudzinski征阴性，无扑翼样震颤。

其他：未见异常。

瑞安市人民医院

住院病历

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：22+10 病历号：8809593

补充及专科情况

T:38.1℃, P:113次/分, R:20次/分, BP:122/74mmHg。神志清楚, 皮肤巩膜无黄染, 口唇无发绀, 浅表淋巴结未触及肿大, 颈静脉无怒张, 气管居中, 胸廓正常, 肋间隙无增宽或缩窄, 双侧触觉语颤对称, 双肺叩诊清音, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 未闻及病理性杂音, 腹部平软, 无压痛, 肝脾肋下未触及, 双下肢无水肿。

辅助检查

2025-12-19 本院 CT胸部平扫:诊断:左肺上叶MT、左侧第3-4肋骨骨折密度改变, 较2025.7.14CT病灶较前缩小, 请结合临床进一步检查。右肺上叶炎症伴包裹性积液、积气, 请结合临床随诊除外其他。两肺肺气肿, 两肺上叶肺大泡。两肺纤维灶。右肺下叶磨玻璃结节灶, 右肺下叶及左肺上叶实性微小结节灶, 较前片右肺下叶结节新发, 请随诊。两侧胸膜增厚。附见:脾-胃间隙占位, 胃来源? 请结合临床进一步检查。肝门区颗粒状淋巴结影。肝右叶钙化灶。;2025-12-20 本院 常规心电图+心电向量:诊断:1、窦性心律2、正常范围心电图;

专项评估:

营养风险筛查: 营养风险评分: 1嘱加强营养摄入, 必要时营养科会诊。

功能评估: 入院ADL评分分级: 100无需康复

宗教信仰: 是否有宗教信仰: ☒ 否 ☐ 是

入院诊断:

1. 社区获得性肺炎, 非重症
2. 肺腺癌 (cT4N3M0)
3. 淋巴结继发恶性肿瘤
4. 腹腔良性肿瘤 (神经鞘瘤)
5. 肝功能不全
6. 肺部结节
7. 脾-胃间隙占位

补充诊断:

1. 低钾血症

最后诊断:

1. 社区获得性肺炎, 非重症
2. 低钾血症
3. 肺腺癌 (cT4N3M0)
4. 淋巴结继发恶性肿瘤
5. 腹腔良性肿瘤 (神经鞘瘤)
6. 肝功能不全

医师签名:  签名时间: 2025-12-20 13:58

医师签名: 金 箫

签名时间: 2025-12-20 09:25



瑞安市人民医院

住 院 病 历

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：22+10 病历号：8809593

7. 肺部结节

8. 脾-胃间隙占位

最后诊断医师签名：王

签名时间：2025-12-26 09:28



瑞安市人民医院

出院记录

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：2204 病历号：8809593

入院日期：2025-12-20

出院日期：2025-12-26

住院天数：6天

入院诊断：1. 社区获得性肺炎，非重症 2. 肺腺癌（cT4N3M0） 3. 淋巴结继发恶性肿瘤 4. 腹腔良性肿瘤（神经鞘瘤） 5. 肝功能不全 6. 肺部结节 7. 脾-胃间隙占位

出院诊断：1. 社区获得性肺炎，非重症 2. 低钾血症 3. 肺腺癌（cT4N3M0） 4. 淋巴结继发恶性肿瘤 5. 腹腔良性肿瘤（神经鞘瘤） 6. 肝功能不全 7. 肺部结节 8. 脾-胃间隙占位

入院情况：

曹启迟，男，55岁，因“咳嗽咳痰3天，发热1天。”入院。查体：T:38.1℃，P:113次/分，R:20次/分，BP:122/74mmHg。神志清楚，皮肤巩膜无黄染，口唇无发绀，浅表淋巴结未触及肿大，颈静脉无怒张，气管居中，胸廓正常，肋间隙无增宽或缩窄，双侧触觉语颤对称，双肺叩诊清音，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，未闻及病理性杂音，腹部平软，无压痛，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。辅助检查：2025-12-19 本院 CT胸部平扫：诊断：左肺上叶MT、左侧第3-4肋骨骨折密度改变，较2025.7.14CT病灶较前缩小，请结合临床进一步检查。右肺上叶炎症伴包裹性积液、积气，请结合临床随诊除外其他。两肺肺气肿，两肺上叶肺大泡。两肺纤维灶。右肺下叶磨玻璃结节灶，右肺下叶及左肺上叶实性微小结节灶，较前片右肺下叶结节新发，请随诊。两侧胸膜增厚。附见：脾-胃间隙占位，胃来源？请结合临床进一步检查。肝门区颗粒状淋巴结影。肝右叶钙化灶。；2025-12-20 本院 常规心电图+心电图向量：诊断：1、窦性心律2、正常范围心电图；

住院期间的辅助检查：

2025-12-19 11:58 本院 血常规(急)+CRP(血液)：淋巴细胞百分比 5.7%；白细胞计数 $11.1 \times 10^9/L$ ；单核细胞百分比 10.5%；中性粒细胞百分比 80.6%；嗜酸性粒细胞百分比 2.9%；红细胞计数 $4.34 \times 10^{12}/L$ ；血红蛋白 128g/L；血小板计数 $189 \times 10^9/L$ ；超敏C反应蛋白 66.20mg/L。2025-12-20 08:55 本院 流感抗原(咽拭子)：甲型流感病毒抗原 阴性；乙型流感病毒抗原 阴性。2025-12-20 11:27 本院 血气+电解质(血)：吸氧浓度 21.0%，酸碱度 (pH) 7.455；氧分压 (PO₂) 70.7mmHg；二氧化碳分压 (PCO₂) 39.3mmHg；钾 3.60mmol/L；氯 103.0mmol/L；钠 134.0mmol/L。2025-12-20 11:57 本院 BNP(血浆)：B型钠尿肽测定 15.2pg/mL。2025-12-20 12:03 本院 肾糖电*, AMY, 急肝, CK, LDH, Lip, β-HB, TG, UA*(血)：肌酐 58μmol/L；尿酸 356μmol/L；天门冬氨酸氨基转移酶 26U/L；AST:ALT 1.96；天门冬氨酸氨基转移酶 51U/L；总蛋白 68.8g/L；白蛋白 41.9g/L；葡萄糖 6.15mmol/L；肌酐 58μmol/L；尿素：肌酐 79.7；钾 3.56mmol/L；钠 138.1mmol/L；氯 103.7mmol/L。2025-12-20 12:06 本院 cTnI, MYO, PCT(急)(血浆)：高敏肌钙蛋白I <3ng/L；肌红蛋白 13.8ng/mL；降钙素原 0.20ng/mL。2025-12-20 12:19 本院 PTS(急), DD(急)(血浆)：正常对照(PT值) 14.4秒；凝血酶原时间 14.4秒；PT活动度 85.0%；国际标准化比值 1.10；正常对照(APTT值) 35.5秒；D-二聚体(定量) 0.74ug/ml。2025-12-20 12:40 本院 流感抗原(咽拭子)：甲型流感病毒抗原 阴性；乙型流感病毒抗原 阴性。2025-12-20 14:42 本院 MP, CP-G, CP-M(血清)：肺炎支原体抗体IgG 136.8AU/mL；肺炎支原体抗体IgM 0.02S/CO；肺炎衣原体抗体IgG 82.7AU/mL；肺炎衣原体抗体IgM 0.96S/CO。2025-12-20 16:00 本院 隐球菌抗原检测(血清)：隐球菌荚膜抗原

瑞安市人民医院

出院记录

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：2204 病历号：8809593

检测（胶体金法）阴性。2025-12-20 16:12 本院 尿常规（尿液）：干化学检验；颜色 浅黄色；浊度 清晰；比重 ≤ 1.005 ；尿酸碱度 5.5；真菌菌丝 0.00/u1。2025-12-21 11:48 本院 新冠核酸-自费（咽拭子）：新型冠状病毒核酸检测 阴性。2025-12-21 11:48 本院 甲乙流、合胞病毒核酸联检，肺支、肺炎、腺病毒核酸联检（咽拭子）：甲型流感病毒RNA 阴性；乙型流感病毒RNA 阴性；呼吸道合胞病毒RNA 阴性；腺病毒DNA 阴性。2025-12-22 本院 ES支气管镜：检查所见：会厌声带：正常气管：正常隆突：尖锐右主支气管：管腔通畅，粘膜光滑。右肺上叶：管腔通畅，粘膜光滑，于右肺上叶灌洗（灌入120ml生理盐水，回收35ml）和尖端刷检。中间支气管：管腔通畅，粘膜光滑。右肺中叶：管腔通畅，粘膜光滑。右肺下叶：管腔通畅，粘膜光滑。左主支气管：管腔通畅，粘膜光滑。左肺上叶：管腔通畅，粘膜光滑。左肺下叶：管腔通畅，粘膜光滑。诊断：支气管镜下未见明显异常。2025-12-22 11:03 本院 G试验，曲霉菌（GM）试验（血清）：曲霉菌抗原检测（GM试验） $<0.1000\mu\text{g/L}$ ；1-3- β -D葡聚糖 $<40.0000\text{pg/ml}$ 。2025-12-23 08:34 本院 曲霉菌（GM）试验（肺泡灌洗液）：曲霉菌抗原检测（GM试验） $<0.1000\mu\text{g/L}$ 。2025-12-23 08:55 本院 FRT,OB（粪便）：颜色 黄色；性状 软便；红细胞 未见/HP；白细胞 未见/HP；隐血试验 阴性。2025-12-23 14:35 本院 多重病原体靶向测序（200+panel）（肺泡灌洗液）：致病性病原体：未检出，条件致病性病原体：肺炎链球菌（11150），人疱疹病毒7型（10998），常见微生物菌群。耐药和毒力：未检出。2025-12-25 06:04 本院 血常规（急），CRP（血液）：白细胞计数 $4.6 \times 10^9/\text{L}$ ；淋巴细胞百分比 15.0%；单核细胞百分比 11.3%；红细胞计数 $3.46 \times 10^{12}/\text{L}$ ；血红蛋白 102g/L ；血小板计数 $201 \times 10^9/\text{L}$ ；超敏C反应蛋白 22.32mg/L 。2025-12-25 06:28 本院 DD（急）（血浆）：D-二聚体（定量） $1.71\mu\text{g/ml}$ 。2025-12-25 06:32 本院 肾糖电*，ALT, TBIL, ALB, CHE, TP, TBA, AST, DBIL*（血浆）：天门冬氨酸氨基转移酶 18U/L ；丙氨酸氨基转移酶 18U/L ；总蛋白 60.4g/L ；白蛋白 38.1g/L ；间接胆红素 $2.0\mu\text{mol/L}$ ；直接胆红素 $<2.0\mu\text{mol/L}$ ；尿酸 $182\mu\text{mol/L}$ ；肌酐 $62\mu\text{mol/L}$ ；钾 3.35mmol/L ；钠 146.0mmol/L ；氯 110.4mmol/L 。

诊疗经过（施行的诊断性和治疗性操作，使用的主要药物等）：

予内护II级，测血压qd，吸氧自定义，莫西沙星针0.4静滴qd抗感染（2025-12-20至2025-12-24），特治星针4.5g静滴q8h（2025-12-23至今）抗感染，溴索雾化等治疗。患者于2025-12-22行支气管镜检查。

出院情况：

症状：患者咳嗽不频繁，不剧，咳少量白色黏痰，无发热寒战，无腹痛腹泻，无头晕头痛，无四肢浮肿等不适。

体征：血压：144/82mmHg。神志清楚，皮肤巩膜无黄染，口唇无发绀，浅表淋巴结未触及肿大，颈静脉无怒张，气管居中，胸廓正常，肋间隙无增宽或缩窄，双侧触觉语颤对称，双肺叩诊清音，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，未闻及病理性杂音，腹部平软，无压痛，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

疗效评价：☐治愈 ☒好转 ☐未愈 ☐死亡 ☐其他（自动出院、转院或其他原因离院）

出院医嘱：

瑞安市人民医院
出院记录

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：2204 病历号：8809593

出院带药：

阿莫西林克拉维酸钾片(基)【出院 4盒】(312.5mg×12) 625mg tid 口服(8天)
(集)氯化钾颗粒(基)【出院 4袋】(1.0g×6) 1g bid 口服(2天)

继续使用的自备药物：

无。

进一步医疗需求筛查：居家康复

随访指导：

复诊时间：2026-01-06

复诊地点：赵仁国主任医师门诊时间：万松院区门诊3楼-329诊室，周二上午、周三下午。陈显静副主任医师门诊时间：万松院区门诊3楼-321诊室，周一下午。

何种情况需紧急到医院就诊：再次出现呼吸困难或出现发热等不适。

其他注意事项：复诊时请携带此出院记录！

1. 休息，避免过度劳累。出院后按医嘱服药，2026-1-06来门诊复查胸部CT。患者肺腺癌（cT4N3M0），淋巴结继发恶性肿瘤，腹腔良性肿瘤（神经鞘瘤），脾-胃间隙占位嘱患者至外院定期随访。
2. 如有不适，及时我院就诊。

医师签名：王军/金箭

签名时间：2025-12-26 09:44



扫描二维码，关注呼吸内科公众号，获取科室最新信息。

呼吸与危重症医学科一(21楼)医师办公室：65866214；呼吸与危重症医学科二(22楼)医师办公室：65866221；呼吸与危重症医学科二(20楼)医师办公室：65866201；
医院咨询、随访热线：0577-58815501/0577-58815881（服务时间：6:00—19:30）

您可以通过以下方式预约门诊：

1. 微信预约：关注“瑞安市人民医院”公众号
2. 支付宝预约：关注“瑞安市人民医院”支付宝生活号
3. 浙里办预约：下载浙里办APP，国民医疗健康服务专区



微信二维码



支付宝二维码



浙里办二维码



瑞安市人民医院

出院记录

姓名：曹启迟 性别：男 科别：呼吸与危重症医学科 床号：2204 病历号：8809593

4. 电话预约：0577-58815881（预约时间：6：00—19：30）；81890000（24小时预约）
5. 医院官网预约：www. rahos. gov. cn
6. 各楼层多功能自助机
7. 现场预约：门诊综合服务中心、各楼层分诊台
8. 诊间预约：门诊就诊后可请医师预约下次复诊（可预约2月内号源）

我院已开展互联网+护理服务项目，如有上门护理或咨询需求，请关注“瑞安市人民医院”微信公众号，点击“门急诊服务”，选择“浙里护理”下单。

如需复印病历，建议您在出院2周后，携带所需资料到门诊一楼综合服务中心办理（工作时间：双休日除外每日8：00-11：30，14：00-17：00，病历复印咨询电话：65866814、58822129）或者登陆瑞安市人民医院微信公众号-个人中心-住院病历复印，进行线上申请快递到家。

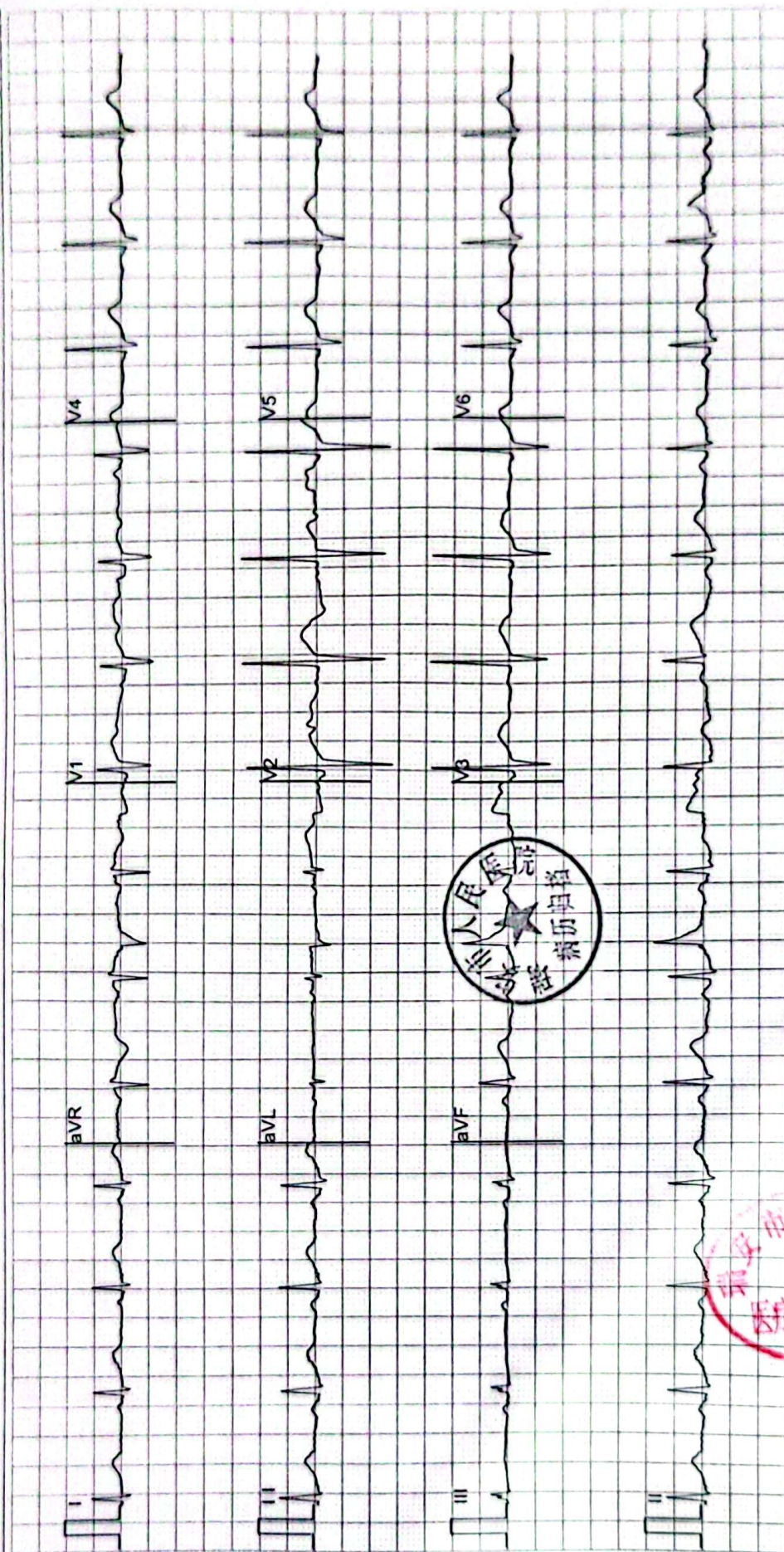


温州医科大学附属第三医院
瑞安市人民医院心电图报告单

姓名: 曹启迟
性别: 男
年龄: 55岁
病历号: 8809593
科室: 呼吸与危重症医学科
床号: 22+10

P : 100
QRS: 88
P-R: 144
QT/QTc : 380/444
QRS电轴: +56
RV5/SV1: 1.26/0.53

心率: 82
RV5 + SV1 = 1.79



心电图诊断:

- 1、窦性心律
- 2、正常范围心电图

纸速: 25mm/s 灵敏度: 10mm/mv BL: ON AC: ON MF: 45Hz

报告医生: *[Signature]* 审核医生: *[Signature]*
检查时间: 2025-12-20 11:45:55
报告时间: 2025-12-20 11:58:07



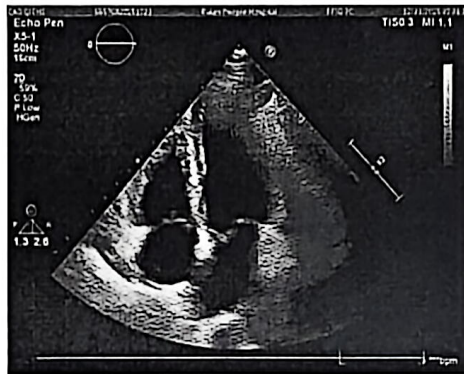
浙江省瑞安市人民医院

超声检查报告单

姓名：曹启迟 性别：男 年龄：55岁 病历号：8809593
床号：22+10 病区：呼吸与危重症病区二 检查设备：EPIQ7(9)
检查项目：经胸心脏超声检查 报告时间：2025-12-23 09:04

超声测量值

AO-a	18mm	16-27mm	AO-s	31mm	23-37mm
AO-asc	31mm	20-35mm	LA-ap	32mm	23-39mm
RV-ap	25mm	15-32mm	IVSd	9mm	6-11mm
LVEDD	45mm	38-54mm	LVEDS	26mm	22-39mm
LVPWd	8mm	6-11mm	MPA	22mm	15-27mm
LVEF	73%	52-77%			



超声描述：

图像质量：良，体位：自如。检查所见：

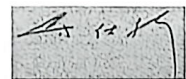
1. 各房室腔大小正常。
2. 左室壁心肌厚度正常，运动协调，未见明显节段性运动异常。
3. 房室间隔结构完整。
4. 二尖瓣回声纤细，开放自如，未见明显反流。
5. 三尖瓣回声纤细，开放自如，未见明显反流。
6. 主动脉内径正常，主动脉瓣呈三尖三叶，无冠瓣部分钙化，开放自如，未见反流。
7. 肺动脉内径正常，肺动脉瓣见微量反流。
8. 心包腔未见明显异常。

超声提示（仅供参考）：

主动脉瓣部分钙化

记录员：钟恬沁 检查医生：寿仕新

审核医生：



注：1. 此报告仅供临床参考，如有疑问，请与检查医生联系 2. 检查医生签字有效 3. 报告单妥善保管，就诊时主动出示

温州医科大学附属第三医院
瑞安市人民医院心向量报告单

姓名: 曹启迟	性别: 男	年龄: 55	病历号: 8809593	门诊号:	科室: 呼吸与危重症医学科	病区及床号: 22+10
---------	-------	--------	--------------	------	---------------	--------------

右侧面 S(Z-Y)

额面 F(X-Y)

横面 H(X-Z)

旋转方向和平面最大向量			
P	运行方向	逆钟向	顺钟向
	mV	0.08	0.04
QRS	运行方向	逆钟向	顺钟向
	mV	0.94	0.99
T	运行方向	逆钟向	顺钟向
	mV	0.24	0.20

QRS环向量初始运行10-40ms			
10 ms	mV	0.01	0.01
20 ms	DEG	-152	-179
	mV	0.05	0.06
30 ms	DEG	-161	137
	mV	0.03	0.27
40 ms	DEG	133	89
	mV	0.51	0.83

QRS环面积			
I象限面积	%	84.53	55.56
II象限面积	%	12.87	1.47
III象限面积	%	2.60	6.00
IV象限面积	%	0.00	36.97
ST向量(mV)		0.10	0.15
T向量环参数			
T环长宽之比		13.5	2.2
R-T夹角	DEG	12	13
最大振幅(QRS/T)	/	3.92	4.95

P, QRS, T环周期(ms)			
Pd	QRSd	Td	
98	118	272	

报告医生: 陈旭

审核医师: 陈旭

检查报告时间: 2025-12-20 11:45:55



瑞安市人民医院
细胞病理学诊断报告单

病理号: Q2025-05008

姓名: 曹启迟 性别: 男 年龄: 55 岁 送检医院: 本院
病历号: 8809593 送检科室: 呼吸与危重症医学科, 收到日期: 2025-12-22
病区: 床号: 报告日期: 2025-12-23

临床诊断: 肺恶性肿瘤: 腺癌, 社区获得性肺炎, 非重症, 肺腺癌
(cT4N3M0) 淋巴管癌变亚性肺病 胸腔恶性肿瘤(神经鞘瘤) 肝功能不

病理诊断:

“纤支镜刷片”见散在柱状上皮细胞、组织细胞, 伴退变, 未见明确肿瘤依据。



报告医生: 杜进京

审核医师:

杜进京

*如送检医师对本诊断有疑问, 请联系本科有关医师。
注: 仅此一份, 遗失不补;

本报告单手工签名或医院盖章有效。



瑞安市人民医院

CT检查报告单



姓名：曹启迟 性别：男 年龄：55岁 影像号：P6061483
病历号：8809593 病区： 床号： 科室：呼吸与危重症医
门诊号：RA04531270 检查日期：2025/12/19 11:27:09
报告日期：2025-12-19 11:39 审核日期：2025-12-19 11:39
检查设备：万松CT三号(GE Optima CT620 62排)
检查项目：胸部平扫

CT所见：

肺MT病史，左肺上叶尖后段(Se4, Im87)见肿块影，其内密度混杂，边缘毛糙，大小约为 $61 \times 41\text{mm}$ ，邻近叶间裂、胸膜牵拉，左侧第3、4肋骨局部骨质密度稍增高、骨皮质欠光整。右肺上叶见片状密度增高影，边界模糊，局部见空气支气管征及包裹性积液、积气。两肺透亮度增加，两肺上叶胸膜下可见多发类圆形透亮影。两肺散在条索状密度增高影，边界尚清。右肺下叶背段(Se4, Im182)见磨玻璃结节，大小约为 $6 \times 5\text{mm}$ 。左肺上叶(Se4, Im143)、右肺下叶(Se4, Im197)见多发实性结节，较大者位于右肺下叶背段(Se4, Im197)，大小约为 $3 \times 2\text{mm}$ 。气管、支气管通畅，两肺门、纵隔见颗粒状淋巴结。心脏、大血管形态如常。两侧胸膜增厚。

CT意见：

左肺上叶MT、左侧第3-4肋骨骨折密度改变，较2025.7.14CT病灶较前缩小，请结合临床进一步检查。
右肺上叶炎症伴包裹性积液、积气，请结合临床随诊除外其他。
两肺肺气肿，两肺上叶肺大泡。两肺纤维灶。
右肺下叶磨玻璃结节灶，右肺下叶及左肺上叶实性微小结节灶，较前片右肺下叶结节新发，请随诊。
两侧胸膜增厚。
附见：脾-胃间隙占位，胃来源？请结合临床进一步检查。肝门区颗粒状淋巴结影。肝右叶钙化灶。

报告医生：钱小曼

审核医生：钱小曼

注：本报告单仅供临床医生参考，不作任何证明；如有疑问或与临床表现不符，请与相关医生联系。